

Dérivation urinaire cutanée continente (poche d'Indiana)

WARWIKI

Information pour le patient · Une poche interne vidée par sonde — sans poche externe

Une dérivation urinaire cutanée continente est une poche interne fabriquée à partir de votre propre intestin. Elle stocke l'urine dans votre corps et s'ouvre sur la peau par une petite stomie étanche (souvent au nombril). Vous videz la poche en introduisant une sonde plusieurs fois par jour — sans poche externe. La poche d'Indiana est la technique la plus utilisée.

À propos de cette intervention

Un segment de **gros et de petit intestin** est reconfiguré en un **réservoir** basse pression à l'intérieur de l'abdomen ; les uretères (canaux reliant les reins) s'y déversent. Un court canal muni d'une **valve anti-retour** est amené à la peau — souvent au **nombril** — sous forme d'une petite stomie plate qui reste sèche entre les sondages.

- Vous introduisez une sonde pour vider la poche environ **toutes les 4 à 6 heures**.
- Vous **irriguez** la poche pour éliminer le mucus.
- **Pas de poche externe** — juste un petit pansement sur la stomie.

Cette solution convient aux personnes qui ne souhaitent pas de poche externe, qui ne peuvent pas (ou ne souhaitent pas) avoir une néovessie, et qui sont capables de **se sonder régulièrement** — ce qui nécessite une bonne dextérité et une bonne vision, ou l'aide d'un soignant.

Est-ce sans danger ?

Il s'agit d'une technique continente bien établie. L'opération est plus longue qu'une dérivation par conduit iléal et implique un auto-sondage à vie. Les risques comprennent : complications chirurgicales (saignement, infection, fistule), difficultés à passer la sonde ou sténose/fuite de la stomie (parfois nécessitant une reprise), calculs dans la poche, mucus, infections urinaires, et modifications à long terme des sels minéraux, des vitamines et de la fonction rénale, surveillées lors du suivi.

COMPRENDRE LES TERMES

Dérivation continente

Système urinaire étanche — vous contrôlez le moment de la vidange.

Poche d'Indiana

La poche continente la plus courante, construite à partir du côlon droit et du petit intestin.

Réservoir (poche)

Le sac interne, fait d'intestin, qui stocke l'urine.

Stomie

La petite ouverture cutanée (souvent le nombril) par laquelle vous passez la sonde.

Auto-sondage

Introduire une fine sonde dans la stomie pour vider la poche.

Irrigation

Rincer la poche avec de l'eau pour éliminer le mucus.

Uretères

Canaux transportant l'urine des reins ; ils se déversent dans la poche.

Mucus

Liquide visqueux produit par l'intestin ; son élimination fait partie des soins quotidiens.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'opération se déroule sous anesthésie générale ; vous ne ressentez rien pendant l'intervention. Après, attendez-vous à des douleurs abdominales, et l'intestin met quelques jours à « se réveiller ». Au réveil, une sonde est placée dans la poche (avec des tuteurs souples) pendant environ 3 à 4 semaines le temps de la cicatrisation — vous l'irriguez pour éliminer le mucus. La plupart des patients rentrent chez eux après 5 à 8 jours.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Intervention sous **anesthésie générale** — respectez toutes les consignes (jeûne, arrêt des anticoagulants si prescrit). Une **préparation intestinale** peut être requise.
- Votre équipe planifie l'emplacement de la **stomie** (souvent le nombril) et vérifie que vous — ou un soignant — pourrez gérer l'**auto-sondage à vie**.
- **Ne fumez pas** et organisez une aide à domicile pour votre retour.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant** ou avez une infection en cours
- Avez une **maladie intestinale**, des problèmes rénaux, ou des difficultés **manuelles ou visuelles** pouvant gêner le sondage

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi sous anesthésie ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Un segment d'intestin est prélevé et le reste de l'intestin est reconnecté.
- 3 L'intestin est reconfiguré en poche ; un canal sondable muni d'une valve est amené à la peau sous forme de stomie.
- 4 Les uretères sont connectés ; une sonde de drainage et des tuteurs souples sont mis en place le temps de la cicatrisation.

Après la chirurgie

- Retour à domicile en **5 à 8 jours** environ, avec la **sonde de poche pendant ~3 à 4 semaines** ; irriguez-la régulièrement.
- Après le retrait de la sonde et la cicatrisation, vous **sondez la stomie toutes les 4 à 6 heures** et irriguez pour éliminer le mucus.
- La stomie reste **sèche** — un petit pansement suffit (pas de poche externe).
- Le mucus est normal ; hydratez-vous bien ; suivi à vie (vitamine B12, contrôle de la poche). **Évitez les efforts lourds pendant ~6 semaines.**

Appelez votre équipe soignante ou consultez en urgence si vous :

- **N'arrivez pas à sonder ou n'obtenez pas d'urine** — la poche doit être vidée en urgence
- Avez de la fièvre ou des frissons
- Avez de fortes douleurs abdominales, des vomissements ou **l'absence de gaz ou de selles**
- Avez un saignement abondant ou des caillots bloquant la sonde, ou une rougeur ou un écoulement de la plaie

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La poche d'Indiana stocke l'urine dans le corps via une petite stomie étanche vidée par sonde, sans poche externe.
2. Vous sondez la stomie toutes les 4 à 6 heures et l'irriguez (mucus), à vie — bonne dextérité et vision (ou un aidant) sont indispensables.
3. Préparez-vous avec le jeûne et la préparation intestinale, ne fumez pas et organisez une aide.